

社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會情境檢核表

操作學員：(主)_____ / (副)_____

指導員：_____

非外傷題幹(主要變化)：第一型糖尿病患者因嘔吐自行停打胰島素，出現高血糖(412 mg/dL)合併 Kussmaul 呼吸與脫水，疑似 DKA。

關鍵處置：血糖監測(實作)、辨識 Kussmaul 呼吸與丙酮味、靜脈輸液(SBP < 90 適應症)、DKA 與 HHS 鑑別。

情境宣達：28 歲男性，呼吸喘、腹痛，呼叫救護車。

所需器材：全套救護器材、血糖機、0.9% 生理食鹽水。

操作時間：不限

項目	標準	不標準	未執行	紀錄
第一部分：現場評估及處置				
現場安全自我防護傳染病控制	☐	☐	☐	
傷病人數與支援需求：1 名	☐	☐	☐	
意識：清醒反應遲鈍	☐	☐	☐	
呼吸道評估：通暢	☐	☐	☐	
呼吸評估：又深又快(36 次/分鐘、有奇怪味道)。	☐	☐	☐	
循環評估：橈動脈雙側對稱微弱／末端肢體乾暖／CRT 3 秒／膚色正常	☐	☐	☐	
氧氣治療：SpO ₂ 85% (Mask 96%)	☐	☐	☐	
輔助檢查： BP：98/62mmHg；HR 118/Min；BT 37.8℃；Glucose 412mg/dl；SP0 ₂ 96%；RR 28 次/分	☐	☐	☐	
血糖監測(實作)：解釋說明 → 備物(採血針、試紙、紙膠、酒精棉) → 選定部位消毒 → 扎針採血 → 加壓止血 → 針具丟棄銳利物桶	☐	☐	☐	
病史詢問： 主訴：噁心嘔吐、腹痛、全身倦怠，持續約 12 小時 之前：在家休養 吃：昨日幾乎未進食 過：糖尿病 藥：胰島素 敏：無食物藥物過敏 感：近日因身體不是故停止施打胰島素	☐	☐	☐	
重點式理學檢查：皮膚乾暖、黏膜乾燥(脫水)、Kussmaul 呼吸、丙酮味、腹部壓痛	☐	☐	☐	
靜脈輸液(實作)：應選擇生理食鹽水	☐	☐	☐	
病情危急度判斷：高血糖、Kussmaul 呼吸、脫水、DKA 急症	☐	☐	☐	
考官詢問：DKA 的典型三大臨床特徵？ 答：①Kussmaul 呼吸(深且快，代償酸中毒) ②丙酮味(脂肪分解產生酮體) ③皮膚乾暖(高血糖性脫水，不同於低血糖的溼冷)	☐	☐	☐	
考官詢問：DKA 與低血糖的皮膚表現有何不同？ 答：DKA：皮膚乾暖(高血糖脫水)；低血糖：皮膚溼冷(交感神經活化大量排汗)	☐	☐	☐	
考官詢問：DKA 與 HHS 最關鍵的鑑別點？ 答：①酮體：DKA 有，HHS 無 ②血糖：DKA > 350，HHS > 600 ③意識：DKA 少見改變，HHS 常見嚴重意識障礙 ④死亡率：HHS 10~50%，遠高於 DKA 的 9~14%	☐	☐	☐	
第二部分：車上評估及處置				
八大生命徵象：意識(E4V4M6)；呼吸 28 下/分鐘(Kussmaul)；脈搏 118 下/分鐘； 血壓 98/62mmHg；體溫 37.8℃；瞳孔等大正常；膚色乾暖	☐	☐	☐	
靜脈注射(實作)：建立靜脈管路(SBP 98mmHg < 90 → 符合靜脈輸液適應症) 0.9% 生理食鹽水快速輸注				
重新評估生命徵象並記錄	☐	☐	☐	

持續監測血糖、呼吸型態與意識		☐ / ☐ / ☐
考官詢問：DKA 為何選用生理食鹽水而非葡萄糖液？		
答：DKA 已高血糖，補充葡萄糖會加重高血糖與酮酸中毒。生理食鹽水用於補充脫水及電解質（Na ⁺ ），改善循環。		
考官詢問：什麼是 euDKA？哪類藥物會引起？		
答：euDKA 為血糖正常（< 250 mg/dL）但仍有酮酸中毒，常由 SGLT-2 抑制劑（如 Jardiance、Forxiga）引起。因血糖正常容易漏診，需高度警覺。		
考官詢問：DKA 最常見的誘發原因？		
答：①感染（最常見） ②自行停用胰島素 ③新發第一型糖尿病 ④心肌梗塞等急性疾病		
靜脈輸液後血壓回升，意識維持清醒，持續監測中 BP(108/70mmHg)/HR 104/SPO ₂ 97%/Glucose 410mg/dl（需院內胰島素治療）		
第三部分：到院後交接		
自我介紹 Identification	☐ / ☐ / ☐	
狀況 Situation	☐ / ☐ / ☐	
背景 Background	☐ / ☐ / ☐	
評估與處置 Assessment	☐ / ☐ / ☐	
建議 Recommendation	☐ / ☐ / ☐	
教官回饋		